

RECURSO CÍVEL Nº 5007177-12.2024.4.02.5103/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA**RECORRENTE:** MARIA DAS GRACAS ELVAS ACACIO (AUTOR)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**EMENTA**

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PATOLOGIA ORTOPÉDICA. DESNECESSIDADE DE PERITO ESPECIALISTA. SENTENÇA BASEADA NO LAUDO PERICIAL. PERÍCIA ADMINISTRATIVA (SABI) NO MESMO SENTIDO DO LAUDO. ENUNCIADO 72 DAS TURMAS RECURSAIS/RJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida. Condene o recorrente em honorários advocatícios, no montante equivalente a 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5007177-12.2024.4.02.5103**510015074544 .V6****RECURSO CÍVEL Nº 5007177-12.2024.4.02.5103/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA**RECORRENTE:** MARIA DAS GRACAS ELVAS ACACIO (AUTOR)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Em sede recursal, a parte autora argumenta que as condições de saúde, como cervicalgia e lumbago com ciática, inviabilizam atividades laborativas e cotidianas, especialmente considerando sua profissão de pescadora, que exige esforço físico intenso. Requer a concessão do benefício desde a data de entrada do requerimento (DER) ou, alternativamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia judicial.

Diante de tais argumentos, o recorrente requer:

a) a reforma da sentença para que o benefício seja concedido desde o primeiro pedido administrativo.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO**DA CONTROVÉRSIA**

Para que o segurado faça jus ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, devem estar preenchidos os requisitos previstos no artigo 59 da Lei 8.213/91, já para o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, os requisitos do art. 42.

Assim, para a concessão dos benefícios em questão, devem restar comprovadas a incapacidade laborativa atestada em laudo pericial, a qualidade de segurado e a carência.

Em sede recursal, a controvérsia é acerca da incapacidade laborativa da parte autora.

DA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL

Conforme fundamentação apresentada pela sentença a quo, nota-se que a perícia judicial esteve atenta a toda documentação médica apresentada pela parte autora, procedendo ao exame físico e psíquico, não sendo constatado indício de incapacidade laborativa.

A perícia é realizada às expensas da Justiça Federal, cujo orçamento está cada vez menor, o que autoriza o juiz a ser mais rigoroso. A propósito, a Lei nº 13.876/19 é expressa no sentido de que, a partir de 2020, será garantido o pagamento de honorários periciais referentes a apenas uma perícia médica por processo judicial. No caso em exame, o perito é especialista para o exame pretendido.

Por conseguinte, descabe a realização de nova prova pericial, mesmo porque os esclarecimentos técnicos ofertados já se mostram suficientes para auxiliar na compreensão dos fatos essenciais ao exame da causa.

Ademais, destaque-se que o entendimento da TNU é no sentido da necessidade de perícia por especialista apenas nos casos complexos e doença rara, o que não é o caso dos autos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA. NECESSIDADE DE PERITO ESPECIALISTA APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS (ALTA COMPLEXIDADE CLÍNICA OU ENFERMIDADE RARA). PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. IMPOSSIBILIDADE DE REVER A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUANTO À NATUREZA DAS ENFERMIDADES ANALISADAS SEM REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 42. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5026062-22.2020.4.02.5101, CAIO MOYSES DE LIMA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 16/06/2023.)

DA INCAPACIDADE LABORATIVA

Compulsando os autos, constato que a autora teve seu pedido de benefício por incapacidade indeferido, devido à ausência de incapacidade laborativa, conforme laudo pericial administrativo (vide evento 3, DOC1). Vejamos:

Requerente: MARIA DAS GRACAS ELVAS ACACIO		NB: 6483577820	
Sexo: Feminino	Nasc.: 21/12/1970	Nº Requer.: 370233637	
Est. Civil:	RG: 214572257	Emissão:	Data Exame: 03/07/2024
Ocupação:		Ordem: 1.00	
RESUMO			
Data Exame: 03/07/2024		CID: M54	
Considerações:			
Historia de lombalgia de longa data. Hoje com exame físico sem alterações que impliquem em incapacidade laborativa para suas atividades. Sem incapacidade laborativa no momento.			
		Resultado: Não existe incapacidade laborativa.	
Benefício:		Início da Doença:	
Auxílio - Doença			
História:		Início da Incapacidade:	
Declara-se Pescadora Artesanal, que não estudou, que não sabe ler nem escrever, 53 anos. Em AX1, sem BI ou indeferimento previo. Relata dor em região de coluna cervical e lombar com irradiação para MMSS e MMII de início há 5 anos. Traz laudo cm rj 52993816 de 28/6/24 M54.2/ M54.4 dor crônica em região coluna cervical e lombar que a incapacita para suas atividades laborais. Apresenta RNM protrusões e abaulamentos discais com patível com o quadro algico apresentado. Oriento necessidade repouso absoluto por tempo indeterminado. RM de 25/5/24 cm rj 52901717 COL CERVICAL protrusões discais em c4c5 e c6c7 sem sinais de compressão da medula espinal. Abaulamento discal posterior em c5c6 sem sinais de compressão da medula espinal.COL LOMBAR diminutas protrusões discais foraminal esq em L4/5 e paramediana em L5/S1 sem redução significativa da amplitude foraminal ou compressão dural, respectivamente. Artrose interapofisária leve em L4/5.		CID: M54	
		Considerações:	
		Historia de lombalgia de longa data. Hoje com exame físico sem alterações que impliquem em incapacidade laborativa para suas atividades. Sem incapacidade laborativa no momento.	

Analisando a perícia judicial, realizada em 10/10/2024, o perito, após a realização de minucioso exame físico, concluiu no memso sentido da a perícia administrativa e reconhece a ausência de incapacidade (vide **evento 17, DOC1**). Vejamos:

Exame físico/do estado mental: Apresenta-se normocorada, normohidratada e normonutrida, sem sinais de doença psiquiátrica, mantendo o discurso lógico e coerente, sem deficit de atenção ou memória, não havendo rebaixamento do humor ou afeto

Aparelho respiratório: eupneico e com ritmo respiratório e ausculta pulmonar regulares

Aparelho cardiovascular: ritmo cardíaco normal, bulhas normofonéticas, sem sopros e com pa 110x80 mmHg. Não há sinais de descompensação ou insuficiência cardíaca que indiquem incapacidade laboral para a função indicada

Sistema musculo esquelético: sem assimetria muscular e palmar que indiquem desuso. Leve rigidez muscular cervical e em quadril, sem limitação de força ou movimentos que possa justificar incapacidade laboral

Teste de Mankopf - manobra para avaliar simulação de dor e consiste em identificar o ritmo basal do pulso radial do autor e verificar se a compressão dos pontos referidos como dolorosos provoca

a elevação de 10% ou mais deste ritmo. No caso em tela, o **resultado foi negativo**

Teste da distração - manobra para avaliar se há melhora da dor ao realizar-se a distração da região cervical, a qual abri os forames neurais - No caso em tela, o **resultado foi negativo**

Teste de Spurling - manobra para avaliar se há dor e aumento dos sintomas radiculares na extremidade quando realiza flexão lateral da cabeça e o examinador realiza pressão sobre o topo da cabeça - No caso em tela, o **resultado foi negativo**

Teste de Adams - manobra para verificar se a inclinação anterior do tronco com as palmas das mãos opostas entre si causa assimetria de membros superiores - No caso em tela, o **resultado foi negativo**

Teste de Wedell - manobra para avaliar se há melhora da dor ao realizar-se a dor à pressão no vértice do crânio, a ausência de dor com a elevação do membro enquanto paciente está distraído ou reações dolorosas exacerbadas e desproporcionais ao estímulo. - No caso em tela, o **resultado foi negativo**

Teste de Hoover - manobra onde os calcanhares são apoiados na palma da mão do examinador e, ao se pedir que eleve o membro afetado, o comum é a pressão do membro contralateral na palma da mão- No caso em tela, o **resultado foi negativo**

Teste de Laségue - manobra de elevação passiva do membro inferior com o joelho em extensão e é considerada positiva quando o paciente sente dor no trajeto do nervo ciático entre 35º e 70º de elevação - No caso em tela, o **resultado foi negativo**

Teste de Fabere/Patrick - teste especial realizado para avaliar as articulação sacroilíaca e do quadril de pacientes que possuem dor lombar, quando é realizado a manobra de flexão, abdução e rotação externa do membro inferior, permitindo ao avaliador realizar um estresse articular na região sacroilíaca, visando reproduzir a dor referida pelo paciente. No caso em tela, o **resultado foi negativo**

Exame neurológico: normal

Exame oftalmológico: normal

Conclusão: sem incapacidade atual

- Justificativa: Conforme o exame físico
- Houve incapacidade pretérita em período(s) além daquele(s) em que o(a) examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário? NÃO
- Caso não haja incapacidade atual, o(a) examinado(a) apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza? NÃO

Importa ressaltar que o simples fato de o(a) segurado(a) do INSS ser acometido por determinada doença, sob controle e acompanhamento médico, medicamentoso, fisioterápico e/ou psicoterapêutico, não implica, por si só, no reconhecimento de efetiva incapacidade para o trabalho.

Destaca-se que foram analisados todos os documentos acostados, bem como as condições pessoais da parte autora, entretanto, estes não são suficientes para a concessão de benefícios previdenciários.

Cabe destacar, que o laudo do perito judicial se mostrou completo e atento a toda a situação da autora, sendo assertivo quanto a capacidade da parte autora de exercer atividade laborativa no momento.

Apesar da parte autora apresentar documentação médica (ev. 1.11 a 1.16), entendo que o seu conteúdo não carrega detalhamento técnico capaz de enfraquecer as constatações do laudo da perícia judicial, o qual é equidistante das partes.

Desse modo, a referida documentação médica não comprova incapacidade atual, não havendo conflitos com as conclusões do laudo pericial deste processo.

Assim, como o perito atestou a capacidade da parte autora e não existem nos autos elementos capazes de impugnar as conclusões do laudo pericial, a sentença deve ser mantida, visto que seus fundamentos não foram afastados pela argumentação recursal.

O Enunciado 72 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por sua vez, dispõe que:

“Não merece reforma a sentença que acolhe os fundamentos técnicos do laudo pericial para conceder ou negar benefício previdenciário ou assistencial quando o recurso não trazer razões que possam afastar a higidez do laudo”.

Importa destacar que nada impede novo requerimento do benefício em tempo posterior, mesmo relativamente curto, eis que se trata de fato novo (agravamento de doença anterior ou nova doença incapacitante), logicamente tendo o(a) interessado(a) que continuar vertendo as contribuições previdenciárias.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença recorrida. Condene o recorrente em honorários advocatícios, no montante equivalente a 10% do valor corrigido da causa, nos termos do **art. 98, § 3º do Código de Processo Civil**. Publique-se. Intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto.

5007177-12.2024.4.02.5103

510015074541 .V6